

A escala MEWS

Conceito

MEWS é a sigla para "**Modified Early Warning Score**" (em português, **Pontuação de Alerta Precoce Modificada**). É uma ferramenta de triagem e alerta precoce, usada para "não deixar escapar" um paciente que está silenciosamente piorando. Ela transforma sinais clínicos subjetivos em um número objetivo que aciona protocolos de ação específicos, melhorando a segurança do paciente.

Trata-se de **um sistema simples e padronizado para identificar precocemente pacientes com risco de deterioração clínica**, ou seja, que estão piorando e podem precisar de cuidados mais intensivos ou até sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Contexto Histórico e a Primeira Publicação

A Escala MEWS não foi "inventada" por uma única pessoa em um único estudo, mas sim **desenvolvida e validada por uma equipe de médicos no Reino Unido na década de 1990**.

Os principais nomes associados à sua criação e primeira publicação formal são:

- **Dr. Gary B. Smith**
- **Dr. David R. Prytherch**
- **E sua equipe do Hospital de Stoke Mandeville, em Buckinghamshire, Inglaterra.**

A MEWS é uma **modificação** de outras "Early Warning Scores" (EWS) que já eram usadas de forma não padronizada. A equipe do Dr. Smith reconheceu a necessidade de um sistema mais simples, válido e confiável.

A primeira publicação científica que descreve formalmente e valida a Escala MEWS é:

- **Título:** "Review and performance evaluation of aggregate weighted 'track and trigger' systems"
- **Autores:** Gary B. Smith, David R. Prytherch, et al.
- **Publicação:** **Resuscitation** (uma revista médica de alto impacto na área de emergência e cuidados intensivos).
- **Ano:** **1997** (com estudos de refinamento e validação publicados nos anos seguintes, como em 2001).

Por que ela foi criada?

O objetivo da equipe era claro: **criar uma ferramenta melhor para identificar precocemente pacientes em deterioração clínica nas enfermarias gerais**, onde a supervisão constante de especialistas em terapia intensiva não está disponível.

Eles pegaram os princípios das EWS existentes e os **modificaram** ("Modified" no nome) com base na análise de dados clínicos reais, refinando os limites dos parâmetros (como frequência cardíaca, respiratória e pressão arterial) para maximizar a sensibilidade (capacidade de detectar um paciente que está realmente piorando) e a especificidade (evitar alarmes falsos). Ela é, portanto, o resultado de um trabalho de pesquisa clínica colaborativo, não de uma descoberta individual isolada, e seu grande mérito foi padronizar e validar uma ferramenta simples que salva vidas.

Como funciona?

A equipe de enfermagem ou médica mede alguns parâmetros fisiológicos vitais do paciente em intervalos regulares (por exemplo, a cada 4, 6 ou 8 horas) e atribui uma pontuação para cada um deles, de acordo com o quão distantes estão do normal.

Detalhamento de Cada Parâmetro:

1. **Frequência Cardíaca (FC):** Avalia se o coração está batendo muito devagar (bradicardia) ou muito rápido (taquicardia), ambos sinais de estresse fisiológico.
2. **Pressão Arterial Sistólica (PAS):** Foca na "pressão máxima". Valores baixos (hipotensão) são particularmente preocupantes, indicando possível choque.
3. **Frequência Respiratória (FR):** Considerado **o parâmetro mais sensível e importante** para detectar deterioração. Um aumento (taquipneia) é frequentemente o primeiro sinal de um paciente em dificuldade.
4. **Temperatura Corporal (TC):** Identifica tanto a hipotermia (temperatura baixa) quanto a febre (temperatura alta), que podem ser causadas por infecção ou outros distúrbios.
5. **Nível de Consciência (AVPU):** É uma versão simplificada da Escala de Coma de Glasgow (GCS). Qualquer alteração no estado de alerta (o paciente não está mais "A") é um sinal de alarme grave e recebe a pontuação máxima (3) para esse parâmetro.

Escala AVPU:

- **A (Alert):** Alerta, consciente.
- **V (Voice):** Responde a estímulos verbais.
- **P (Pain):** Responde apenas a estímulos dolorosos.
- **U (Unresponsive):** Inconsciente, não responde.

Tabela de Pontuação (Exemplo Simplificado)

Cada desvio do normal recebe uma pontuação (geralmente de 0 a 3).

Parâmetro	3	2	1	0	1	2	3
FC (bpm)	≤ 40	41-50	51-100	101-110	111-129	≥ 130	
PAS (mmHg)	≤ 70	71-80	81-100	101-199		≥ 200	
FR (rpm)	≤ 8		9-14	15-20	21-29	≥ 30	
TC (°C)	≤ 35.0		35.1-36.0	36.1-38.0	38.1-38.5	≥ 38.6	
AVPU				A			V, P ou U

Interpretação da Pontuação Total

A pontuação de todos os parâmetros é somada, resultando em um **score MEWS total**.

- **Score 0 - 2: Baixo Risco.** Geralmente, continua a monitoração de rotina.
- **Score 3 - 4: Risco Moderado.** Aumentar a frequência de observação e informar a equipe de enfermagem sênior ou o médico responsável.
- **Score ≥ 5: Alto Risco.** Sinal de alerta significativo. Requer avaliação médica **imediate** e consideração de transferência para uma unidade de cuidados mais intensivos (como UTI). É comum acionar uma equipe de resposta rápida (RRT - Rapid Response Team).

Objetivos e Vantagens da Escala MEWS

- **Padronização:** Oferece uma linguagem comum para toda a equipe.
- **Deteção Precoce:** Permite identificar sinais sutis de piora antes que se torne uma emergência irreversível.
- **Melhora na Comunicação:** Facilita a comunicação entre enfermagem e medicina, pois um "score MEWS 6" é um alerta objetivo e inequívoco.
- **Tomada de Decisão:** Orienta ações clínicas baseadas em evidências (aumentar monitoração, chamar o médico, acionar a RRT).

Conceito do Aplicativo: MEWS Guardian

Visão Geral

O **MEWS Guardian** é um aplicativo projetado utilizando Sistemas Multiagentes (SMA), para auxiliar profissionais de saúde na avaliação rápida e padronizada de pacientes utilizando a Escala MEWS, fornecendo **recomendações clínicas baseadas em evidências** para cada pontuação obtida. Representa uma ferramenta valiosa para melhorar a segurança do paciente e a qualidade da assistência em cenários onde a detecção precoce da deterioração clínica é crucial.

Funcionalidades Principais

1. Interface de Entrada de Dados

- Campos intuitivos para inserção dos 5 parâmetros MEWS. Os campos podem ser inseridos de forma manual e/ou recebidos por sensores específicos ligados ao paciente:
 - Frequência Cardíaca (bpm)
 - Pressão Arterial Sistólica (mmHg)
 - Frequência Respiratória (rpm)
 - Temperatura (°C)
 - Nível de Consciência (menu dropdown AVPU)

2. Cálculo Automático e Classificação

- Cálculo instantâneo do score total (0-15+)
- Classificação por cores:
 - **Verde** (0-2): Baixo Risco
 - **Amarelo** (3-4): Risco Moderado
 - **Vermelho** (≥5): Alto Risco

3. Sistema de Recomendações Baseadas em Evidências

Para Score 0-2 (Verde)

Interpretação Clínica:

Significado: Paciente estável, parâmetros dentro da normalidade ou com desvios mínimos.

Possíveis Causas:

- *Condição clínica controlada*
- *Pós-operatório estável*
- *Doença de base compensada*
- *Variações fisiológicas normais*

Riscos e Consequências se Negligenciado:

- *Baixo risco de deterioração iminente*
- *Possibilidade de evolução lenta para condições agudas*
- *Risco de complacência da equipe*

Procedimentos recomendados:

ENFERMAGEM

MONITORAMENTO DE ROTINA

- Verificar sinais vitais a cada 4-8 horas conforme protocolo;
- Manhorar observação para mudanças no padrão respiratório;
- Documentar evolução no prontuário;
- Manhorar comunicação com equipe sobre qualquer alteração subjetiva;
- Orientar paciente/família sobre sinais de alerta.

MÉDICOS:

CONDUTA MÉDICA

- Manter plano terapêutico estabelecido;
- Reavaliar prescrições nas próximas 24h;
- Considerar necessidade de exames complementares de rotina.

Para Score 3-4 (Amarelo)

Interpretação Clínica:

Significado: Sinais precoces de deterioração. Sistema fisiológico começando a compensar estresse.

Possíveis Causas:

- **Infecção incipiente** (sepse precoce)
- **Desidratação** moderada
- **Dor** não controlada
- **Ansiedade/agitação**
- **Anemia** sintomática
- **Insuficiência respiratória inicial**
- **Alterações metabólicas** leves

Riscos e Consequências se Negligenciado:

- Progressão para falência orgânica em 24-48 horas
- Aumento de 3x no risco de transferência para UTI
- Maior mortalidade em 30 dias
- Possibilidade de parada cardiorrespiratória evitável

Procedimentos Recomendados:

ENFERMAGEM (AÇÕES IMEDIATAS):

- Aumentar frequência de observações para CADA 2 HORAS;
- Verificar saturação periférica de oxigênio (SpO2);
- Realizar glicemia capilar;
- Comunicar ao enfermeiro sênior IMEDIATAMENTE;
- Notificar médico responsável dentro de 2 HORAS;
- Reavaliar score MEWS em 1 HORA.

MÉDICOS (AÇÕES DENTRO DE 2 HORAS):

- **CONDUTA MÉDICA - RISCO MODERADO**
 - Avaliação clínica completa focando:
 - - Fonte infecciosa;
 - - Estado volêmico;
 - - Controle da dor;
 - - Função renal.
 - Solicitar exames complementares:
 - - Hemograma completo;
 - - Função renal (ureia/creatinina);
 - - Eletrólitos;
 - - Proteína C reativa (PCR);
 - - Gasometria venosa se FR >20.
 - Intervenções específicas:
 - - Otimizar analgesia se dor presente;
 - - Reposição volêmica se desidratado;
 - - Antibioticoterapia empírica se suspeita infecciosa;
 - - Considerar suplementação de O2 se SpO2 <92%.

Para Score ≥5 (Vermelho)

Interpretação Clínica:

Significado: Deterioração clínica significativa. Risco iminente de falência orgânica.

Possíveis Causas:

- **Sepse grave/choque séptico**
- **Hemorragia** significativa
- **Insuficiência respiratória aguda**
- **Arritmia** maligna
- **Edema agudo de pulmão**
- **Trauma** não identificado
- **Overdose/toxidrome**
- **Acidente vascular cerebral**

Riscos e Consequências se Negligenciado:

- **Mortalidade hospitalar aumentada em 5x**
- **Risco de parada cardiorrespiratória em 24h**
- **Lesão orgânica permanente**
- **Necessidade de ventilação mecânica**
- **Choque refratário**

Procedimentos Recomendados:**ENFERMAGEM (AÇÕES IMEDIATAS - PRIMEIROS 15 MINUTOS):****EMERGÊNCIA MÉDICA - PROTOCOLO VERMELHO****ATIVACÃO DO SISTEMA:**

- Acionar Equipe de Resposta Rápida (RRT) ou médico plantonista URGENTE;
- Preparar carro de emergência/carro de parada.

MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA:

- Monitorizar ECG, SpO2, PAS continuamente;
- Manhorar via aérea pérvia - posicionamento adequado;
- Administrar Oxigênio suplementar 10-15L/min via máscara não-reinalante.

PREPARAÇÃO DE ACESSOS:

- Obter 2 acessos venosos calibrosos (14G ou 16G);
- Coletar exames laboratoriais: hemograma, coagulograma, lactato;
- Manter via venosa permeável com SF 0,9%.

DOCUMENTAÇÃO CRÍTICA:

- Registrar hora de início da deterioração;
- Documentar todas as intervenções;
- Preparar prontuário para transferência.

MÉDICOS/EQUIPE DE RESPOSTA RÁPIDA (AÇÕES DENTRO DE 30 MINUTOS):**CONDUTA MÉDICA - ALTO RISCO VITAL****AVALIAÇÃO RÁPIDA ABCDE:**

- **A (VIA AÉREA):** Verificar patência, considerar intubação se GCS <8;
- **B (RESPIRAÇÃO):** Ausculta pulmonar, avaliar necessidade de ventilação;
- **C (CIRCULAÇÃO):** Avaliar enchimento capilar, pulsos, pressão arterial;
- **D (DISFUNÇÃO NEUROLÓGICA):** Reavaliar AVPU, pupilas;
- **E (EXPOSIÇÃO):** Procurar fontes de sangramento, sinais de infecção.

INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA RÁPIDA:

- Gasometria arterial;
- Radiografia de tórax;
- ECG 12 derivações;
- Lactato arterial/venoso;
- Ecografia point-of-care (FATE).

INTERVENÇÕES ESPECÍFICAS:

- **SEPSE:** Antibioticoterapia em 1h + reposição volêmica agressiva;
- **HEMORRAGIA:** Reposição sanguínea + identificação da fonte;
- **CARDIOLÓGICO:** Nitratos, diuréticos, antiarrítmicos conforme indicação;
- **NEUROLÓGICO:** Neuroimagem urgente.

PREPARAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA:

- Contactar UTI/CTI para reserva de leito;
- Preparar documento de transferência;
- Mobilizar equipamento de transporte monitorizado.

4. Sistema de Recomendações Específicas por Parâmetro Alterado

Exemplo para FR ≥ 30 rpm:

TAQUIPNEIA SIGNIFICATIVA

- Verificar saturação de O₂
- Administrar oxigênio suplementar se SatO₂ <92%
- Avaliar para: pneumonia, embolia pulmonar, acidose
- Considerar suporte ventilatório

Exemplo para PAS ≤ 70 mmHg:

HIPOTENSÃO GRAVE

- Avaliar perfusão periférica
- Iniciar/aumentar reposição volêmica se indicado
- Considerar vasopressores
- Excluir sangramento ativo

5. Sistema de Recomendações Específicas por parâmetro crítico

Para FR ≥ 30 rpm:

Insuficiência respiratória iminente

Possíveis causas:

- Pneumonia/Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo
- Embolia Pulmonar
- Acidose Metabólica (cetoacidose, lactacidose)
- Ansiedade/Dor extrema

Consequências:

- Fadiga muscular respiratória
- Falência ventilatória em 2-6 horas
- Hipoxemia grave

Ações:

- O₂ de alto fluxo via máscara não-reinalante
- Gasometria arterial URGENTE
- Preparar para intubação orotraqueal
- Radiografia de tórax imediata

Para PAS ≤ 70 mmHg:

Choque iminente

Possíveis causas:

- Choque Séptico (vasodilatação)
- Choque Hipovolêmico (sangramento/desidratação)
- Choque Cardiogênico (IAM, arritmia)
- Choque Anafilático

Consequências:

- Hipoperfusão orgânica (renal, cerebral, coronariana)
- Lesão renal aguda
- Isquemia miocárdica
- Morte encefálica em minutos

Ações:

- Reposição volêmica agressiva (30ml/kg SF 0,9%)
- Vasopressores se refratário (Noradrenalina)
- Identificar e tratar causa base
- Monitorização hemodinâmica invasiva

Para Nível de Consciência V/P/U:

Alteração do nível de consciência - grave

Possíveis causas:

- Hipóxia grave
- Hipotensão significativa
- Acidente Vascular Cerebral
- Overdose medicamentosa
- Distúrbio metabólico grave
- Convulsão

Consequências:

- Aspiração pulmonar
- Obstrução de via aérea
- Parada respiratória

Ações:

- Posicionamento em DLE se sem trauma
- Considerar intubação protetora
- Glicemia capilar IMEDIATA
- Tomografia de crânio URGENTE
- Antídotos específicos se indicado

Fluxograma de decisão clínica

SCORE MEWS	INTERPRETAÇÃO	AÇÕES ESPECÍFICAS	REAVALIAÇÃO
0-2	Estável	Monitoração 4-8h	Se piora: reclassificar
3-4	Alerta	Ações em 2h	Reavaliar em 1h
≥5	Emergência	Ações em 30min	Reavaliar continuamente

Este nível de detalhamento permite não apenas a ação, mas o entendimento fisiopatológico necessário para decisões clínicas assertivas e tratamento adequado da causa base.

Funcionalidades Avançadas

1. Histórico e Tendências

- Gráficos temporais da evolução do score
- Alertas para piora progressiva (ex: aumento de 2 pontos em 4h)

2. Checklist de Ações

- Listas verificáveis para cada protocolo
- Temporizador para próximas reavaliações

3. Integração com Protocolos Hospitalares

- Customização conforme protocolos institucionais
- Números de telefone de emergência integrados

4. Modo Offline

- Funcionalidade completa sem internet
- Sincronização quando conexão disponível

Benefícios Esperados

1. **Padronização:** Garante que todos os profissionais sigam os mesmos protocolos
2. **Agilidade:** Reduz tempo entre identificação e ação
3. **Educação Contínua:** Funciona como ferramenta de treinamento
4. **Documentação:** Facilita registro preciso das intervenções
5. **Segurança do Paciente:** Minimiza erros de interpretação

Público-Alvo

- Enfermeiros
- Médicos plantonistas
- Equipes de resposta rápida
- Estudantes de medicina e enfermagem
- Técnicos de enfermagem (sob supervisão)

Considerações Importantes

- **Caráter Suplementar:** Não substitui o julgamento clínico
- **Personalização:** Adaptável a diferentes contextos hospitalares
- **Validação Clínica:** Desenvolvido com base em diretrizes nacionais e internacionais

Referências Científicas Fundamentais

1. Publicações Originais e Validação

- **Smith GB, Prytherch DR, et al.**
 - *"Review and performance evaluation of aggregate weighted 'track and trigger' systems"* (Resuscitation, 1997)
 - *"The ability of the National Early Warning Score (NEWS) to discriminate patients at risk of early cardiac arrest, unanticipated intensive care unit admission, and death"* (Resuscitation, 2013)

2. Diretrizes Internacionais

- **Royal College of Physicians (Londres)**
 - National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS (2017)
- **Society of Critical Care Medicine**
 - *"Guidelines for the use of rapid response systems"* (Critical Care Medicine)
- **European Resuscitation Council**
 - *"Guidelines for resuscitation"* (Seção sobre prevenção de parada cardiorrespiratória)

3. Fontes por Categorias Específicas

Para Parâmetros Fisiológicos e Limites:

- **Cretikos MA, et al.** *"The objective medical emergency team activation criteria: a case-control study"* (Resuscitation, 2007)
- **Subbe CP, et al.** *"Validation of a modified Early Warning Score in medical admissions"* (QJM, 2001)

Para Estratificação de Risco e Desfechos:

- **Patel MS, et al.** *"Impact of a national early warning score on hospital mortality"* (Clinical Medicine, 2019)
- **Gerry S, et al.** *"Early warning scores for detecting deterioration in adult hospital patients"* (Cochrane Database Systematic Review, 2020)

Para Protocolos de Intervenção:

- **DeVita MA, et al.** *"Findings of the first consensus conference on medical emergency teams"* (Critical Care Medicine, 2006)
- **Jones DA, et al.** *"Effect of an education programme on the utilization of a medical emergency team"* (Resuscitation, 2011)

4. Referências Institucionais Brasileiras

Protocolos Nacionais:

- **Ministério da Saúde Brasil**
 - *"Protocolo de Segurança do Paciente na Assistência à Saúde"*
 - *"Diretrizes para implantação de Sistemas de Resposta Rápida no Brasil"*
- **ANVISA**
 - *"Protocolo de Prevenção de Parada Cardiorrespiratória"*
- **Conselho Federal de Enfermagem (COFEN)**
 - *"Protocolos de Enfermagem para Monitorização de Pacientes Graves"*

5. Fontes para Desenvolvimento de Aplicativos em Saúde

Segurança e Validação Clínica:

- **FDA - Food and Drug Administration**
 - *"Digital Health Software Precertification Program"*
- **ISO Standards**
 - *"ISO 13485: Medical devices - Quality management systems"*
 - *"ISO 14971: Application of risk management to medical devices"*

Usabilidade em Saúde:

- **International Organization for Standardization**
 - *"ISO 62366: Application of usability engineering to medical devices"*
- **Nielsen Norman Group**
 - *"Usability Guidelines for Medical Devices"*

6. Referências Educacionais

Para Treinamento e Implementação:

- **American Heart Association**
 - *"Advanced Cardiac Life Support (ACLS) Provider Manual"*
- **American Association of Critical-Care Nurses**
 - *"AACN Protocols for Progressive Care"*
- **Sociedade Brasileira de Enfermagem em Urgência e Emergência (SOBRENFe)**

7. Estudos de Implementação e Resultados

Efetividade Clínica:

- **McGaughey J, et al.** *"Outreach and Early Warning Systems (EWS) for the prevention of intensive care admission and death of critically ill adult patients on general hospital wards"* (Cochrane Database, 2017)
- **Alam N, et al.** *"The impact of the use of the Early Warning Score (EWS) on patient outcomes: A systematic review"* (Resuscitation, 2014)

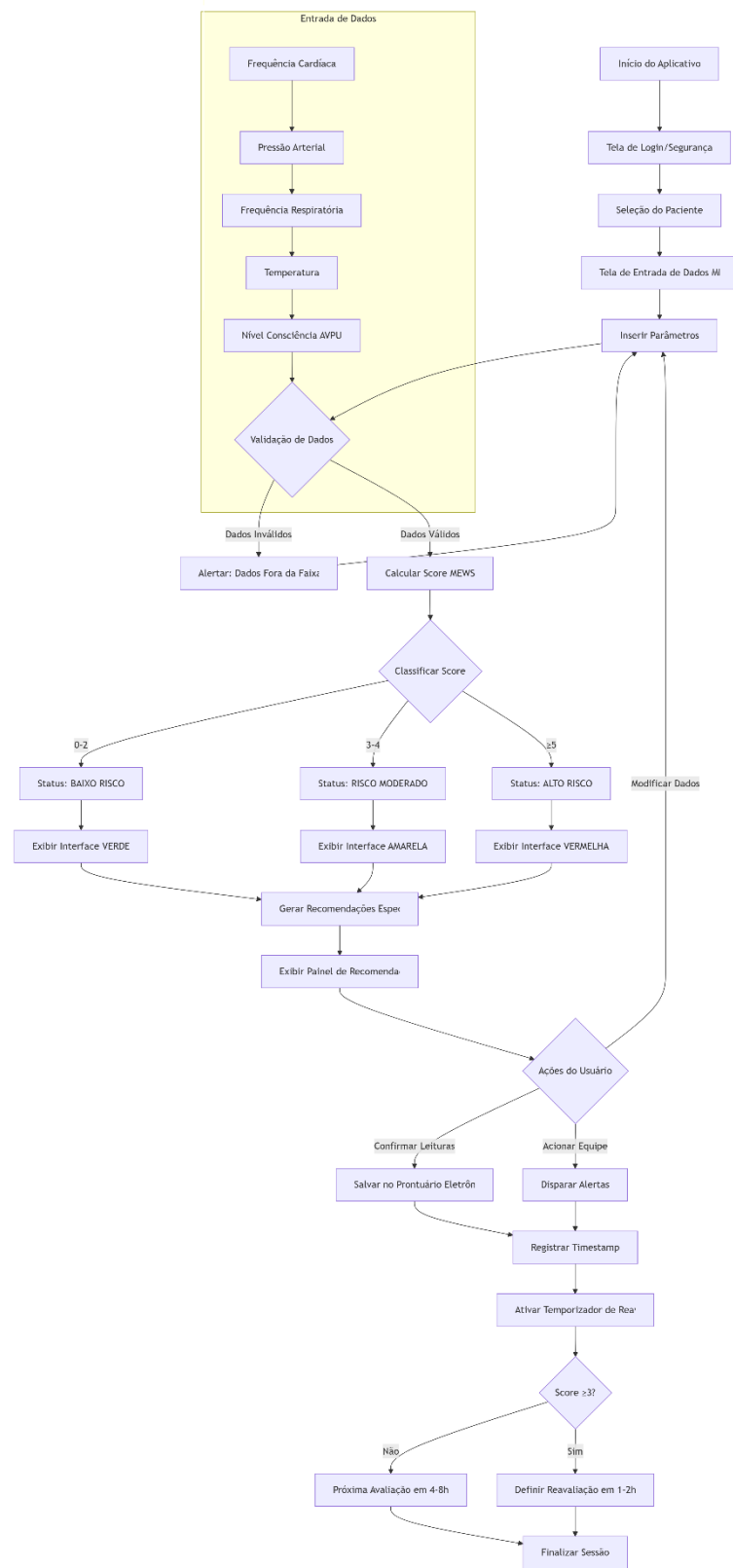
8. Fontes para Inovação em Saúde Digital

- **WHO - World Health Organization**
 - *"Digital Health Guidelines"* (2019)
- **HL7 International**
 - *"Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) Specification"*
- **The Joint Commission**
 - *"National Patient Safety Goals"*

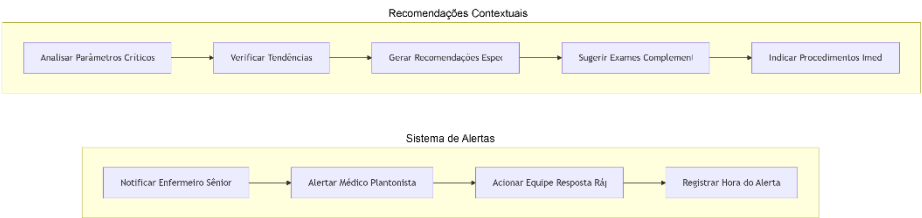
Como Essas Fontes Foram Utilizadas:

1. **Validação dos Limites Numéricos** → Smith, Subbe
2. **Estratificação de Risco** → Royal College, Patel
3. **Protocolos de Intervenção** → DeVita, Jones
4. **Segurança do Paciente** → Ministério da Saúde, ANVISA
5. **Desenvolvimento Tecnológico** → FDA, ISO
6. **Evidências de Efetividade** → Cochrane, Alam

Fluxograma Geral do Sistema



Fluxograma do Sistema de Recomendações e Alertas



RESUMO

A escala MEWS

Conceito

MEWS é a sigla para "**Modified Early Warning Score**" (em português, **Pontuação de Alerta Precoce Modificada**). É uma ferramenta de triagem e alerta precoce, usada para "não deixar escapar" um paciente que está silenciosamente piorando. Ela transforma sinais clínicos subjetivos em um número objetivo que aciona protocolos de ação específicos, melhorando a segurança do paciente.

Contexto Histórico e a Primeira Publicação

A Escala MEWS não foi "inventada" por uma única pessoa em um único estudo, mas sim desenvolvida e validada por uma equipe de médicos no Reino Unido na década de 1990. É uma modificação de outras "Early Warning Scores" (EWS) que já eram usadas de forma não padronizada. A equipe do Dr. Gary B. Smith reconheceu a necessidade de um sistema mais simples, válido e confiável.

Por que ela foi criada?

O objetivo da equipe era claro: criar uma ferramenta melhor para identificar precocemente pacientes em deterioração clínica nas enfermarias gerais, onde a supervisão constante de especialistas em terapia intensiva não está disponível.

Como funciona?

A equipe de enfermagem ou médica mede alguns parâmetros fisiológicos vitais do paciente em intervalos regulares (por exemplo, a cada 4, 6 ou 8 horas) e atribui uma pontuação para cada um deles, de acordo com o quão distantes estão do normal.

Detalhamento de Cada Parâmetro:

- Frequência Cardíaca (FC);**
- Pressão Arterial Sistólica (PAS);**
- Frequência Respiratória (FR);**
- Temperatura Corporal (TC);**
- Nível de Consciência (AVPU):** É uma versão simplificada da Escala de Coma de Glasgow (GCS). Escala AVPU:
 - A** (Alert): Alerta, consciente.
 - V** (Voice): Responde a estímulos verbais.
 - P** (Pain): Responde apenas a estímulos dolorosos.
 - U** (Unresponsive): Inconsciente, não responde.

Tabela de Pontuação (Exemplo Simplificado)

Cada desvio do normal recebe uma pontuação (geralmente de 0 a 3).

Parâmetro	3	2	1	0	1	2	3
FC (bpm)	≤ 40	41-50	51-100	101-110	111-129	≥ 130	
PAS (mmHg)	≤ 70	71-80	81-100	101-199		≥ 200	
FR (rpm)	≤ 8		9-14	15-20	21-29	≥ 30	
TC (°C)	≤ 35.0		35.1-36.0	36.1-38.0	38.1-38.5	≥ 38.6	
AVPU				A			V, P ou U

Interpretação da Pontuação Total

A pontuação de todos os parâmetros é somada, resultando em um **score MEWS total**.

- **Score 0 - 2: Baixo Risco.** Geralmente, continua a monitoração de rotina.
- **Score 3 - 4: Risco Moderado.** Aumentar a frequência de observação e informar a equipe de enfermagem sênior ou o médico responsável.
- **Score $\geq$ 5: Alto Risco.** Sinal de alerta significativo. Requer avaliação médica **imediate** e consideração de transferência para uma unidade de cuidados mais intensivos (como UTI). É comum acionar uma equipe de resposta rápida (RRT - Rapid Response Team).

Objetivos e Vantagens da Escala MEWS

- **Padronização:** Oferece uma linguagem comum para toda a equipe.
- **Detecção Precoce:** Permite identificar sinais sutis de piora antes que se torne uma emergência irreversível.
- **Melhora na Comunicação:** Facilita a comunicação entre enfermagem e medicina, pois um "score MEWS 6" é um alerta objetivo e inequívoco.
- **Tomada de Decisão:** Orienta ações clínicas baseadas em evidências (aumentar monitoração, chamar o médico, acionar a RRT).

Escalas EWS para diferentes caracterizações grupos de pacientes:

- **Por gênero;**
- **Por faixa etária;**
- **Por comorbidades:**
 - Hipertensão arterial;
 - Diabetes Mellitus;
 - Dislipidemia
 - Outras...
- **Cirurgia:**
 - Ortopédica;
 - Gastrointestinal;
 - Cardíaca;
 - Neurológica;
 - Urológica;
 - Ginecológica;
 - Outras...
- **Por 'tipos' de pacientes:**
 - Pediátrico;
 - Geriátrico;
 - Obesos;
 - Gestantes;
 - Outros...

Parâmetros de monitoramento (Escala MEWS):

1. Frequência Cardíaca (FC);
2. Pressão Arterial Sistólica (PAS);
3. Frequência Respiratória (FR);
4. Temperatura Corporal (TC);
5. Nível de Consciência (AVPU).

Parâmetros relevantes adicionais/específicos:

1. Saturação periférica de oxigênio (SpO2)
2. Gasometria arterial;
3. Monitorização hemodinâmica invasiva;
4. Glicemia capilar;
5. Outros...

Perguntas:

Quais são os parâmetros de monitoramento relevantes para cada um desse grupos/subgrupos?